

Priorización Inteligente y Reordenamiento de Listas de Espera Sanitarias

Alineación con la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP)

Enfoque: Estratificación de Riesgo y Triage Dynamic	Línea del Lab: Línea 02 (Descompresión)	Marco: Estratificación ECICEP
--	--	--------------------------------------

1. CONTEXTO Y CRITERIO INSTITUCIONAL

Frente a la presión asistencial sobre el sistema público chileno, el Ministerio de Salud ha implementado la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP), orientada a transformar la atención mediante la estratificación del riesgo y la continuidad del cuidado. La demanda asistencial se agrupa operativamente en cuatro niveles:

- 1. Primera Consulta de Especialidad:** Derivaciones mediante interconsultas desde Atención Primaria o secundaria.
- 2. Controles y Seguimiento:** Evaluaciones periódicas, revisión de exámenes y monitoreo de pacientes crónicos o post-intervención.
- 3. Intervenciones Quirúrgicas:** Pacientes en espera de cirugías electivas programadas.
- 4. Procedimientos Diagnósticos/Terapéuticos:** Exámenes complejos y procedimientos ambulatorios.

Actualmente, la asignación de horas tiende a basarse en la antigüedad de la solicitud o en intervalos fijos. Esto genera ineficiencias: pacientes con deterioro clínico progresivo enfrentan esperas prolongadas, mientras que casos estabilizados ocupan cupos presenciales que podrían reprogramarse con seguridad.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema de priorización inteligente y triage longitudinal mediante Inteligencia Artificial que organice dinámicamente los cuatro niveles de la lista de espera bajo los principios de la ECICEP, asignando la prioridad de atención en función del riesgo clínico real, la complejidad patológica y la vulnerabilidad del paciente.

3. COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN PROPOSTA

- **Análisis Multivariable y Multinivel:** Ingesta automatizada de solicitudes, fichas e informes clínicos para estructurar y clasificar las solicitudes según las categorías de la ECICEP.
- **Algoritmo de Triage Dinámico por Riesgo Real:** Evaluación continua de comorbilidades, progresión sintomática y variables sociodemográficas para asignar un índice de prioridad relativo.
- **Optimización de Frecuencia de Controles:** Identificación de pacientes en seguimiento (nivel 2) con indicadores de estabilidad prolongada, sugiriendo el distanciamiento seguro de sus citas o su derivación a seguimiento remoto, liberando capacidad presencial.
- **Panel de Gestión para Unidades de Demanda (UGD):** Interfaz de soporte a la decisión que presenta las listas reordenadas junto con la justificación clínica transparente de cada recomendación.

4. PRINCIPIOS SANITARIOS Y FRAMEWORK TÉCNICO

Soporte a la Decision Clinica: El sistema opera estrictamente como una herramienta de apoyo a la gestión sanitaria. La validación del reordenamiento de agendas y la citación final corresponden a la Unidad de Gestión de la Demanda y al equipo médico.

El desarrollo utilizará el stack de Claude de Anthropic (API de Claude, Agent SDK y Model Context Protocol) para realizar razonamiento estructurado sobre conjuntos de datos clínicos anonimizados y sintéticos.

5. IMPACTO ESPERADO

- **Reducción de complicaciones en espera:** Detección temprana y citación prioritaria de pacientes con riesgo inminente de descompensación.
- **Uso eficiente de la capacidad instalada:** Reasignación de cupos liberados en controles estables hacia primeras consultas y procedimientos urgentes.
- **Equidad en el acceso:** Transición de una lógica de citación por antigüedad a un modelo equitativo basado en la necesidad de salud real.